

УДК 616.24-006.6

Ж.Ж. Жолдыбай^{1,2}, Ж.К. Жакенова², А.Н. Ахмұльдинова^{2,3}, Ш.Н. Кудобаева⁴, А.Ю. Талипова⁴¹Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы²КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы³ЦГКБ, г. Алматы,⁴ЦРБ, Алматинская обл.

Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся синдромом консолидации в ЛЕГКОМ

Аннотация. В данной работе представлены определения и результаты исследования заболеваний, сопровождающиеся синдромом консолидации. Анализ результатов лучевых методов исследования (рентгенография, компьютерная томография) 68 пациентов с синдромом консолидации в легких. Выявлены значимые лучевые дифференциально-диагностические критерии для туберкулеза, пневмонии и рака легкого.

Ключевые слова: рентгенография, компьютерная томография, синдром консолидации, диагностические критерии.

Актуальность

Показатели смертности от заболеваний органов дыхания в РК в 2013 году составили 67,2‰ и увеличились на 10‰ (17,4%) по сравнению с 2012 г. [1]. Сегодня изменилось соотношение заболеваний легких, выявляемых с помощью рентгенологического метода, – 70 лет назад среди всех легочных заболеваний доля туберкулеза составляла 95%, в настоящее время доля этого заболевания не превышает 40-50%. Рентгенография является «золотым стандартом» в выявлении и диагностике легочных заболеваний. [2]. Поздняя диагностика и высокие показатели заболеваемости органов дыхания у нас в стране, иногда недооценка клинических данных и рентгенологического метода явились пусковым механизмом для изучения лучевой семиотики заболеваний, сопровождающихся синдромом консолидации на рентгенограммах и КТ-срезах.

Определение. Синдром консолидации (радиологически) – ограниченное затемнение, сопровождающееся повышением плотности легочной ткани; как правило, легочный рисунок не прослеживается на фоне затемнения. Легочная консолидация – это уплотнение легочной ткани за счет заполнения воздушных альвеол содержимым. Синдром консолидации могут давать пневмонии, инфильтративный туберкулез, рак легкого, пневмофиброз и другие.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов лучевых методов исследования 68 пациентов с синдромом консолидации, проходивших лучевое обследование с подозрением на пневмонию. Рентгенологическое обследование органов

грудной клетки проведено 68 (100%) пациентам, из них компьютерная томография сделана 34 (50%) пациентам. Распределение по полу среди обследованных пациентов было следующим – 28 (41,1%) женщин (средний возраст 56,8±18,4 лет) и 40 (58,9%) мужчин (средний возраст 60,0±19,4 лет). Клинико-лабораторными и рентгенологическими методами пневмония установлена в 50 (73,5%) случаях, туберкулез легких – в 5 (7,3%) случаях, рак легкого – в 9 (13,2%) случаях, метастатическое поражение легких в 2 (3,0%) случаях, ХНЗЛ в 2 (3,0%) случаях. В процессе лечения у 62 (91,2%) пациентов была оценена рентгенологическая динамика основного процесса в легких.

Статистический анализ проводился с помощью программы SPSSStatistica 17.0.

Результаты. Пневмония составляла большинство наблюдений в нашем исследовании (50 – 73,5%) среди 68 пациентов с синдромом консолидации в легком. Дифференциально-диагностическими критериями пневмонии на рентгенограммах были нарастание интенсивности затемнения от центра к периферии (74,0%), завуалированность просвета промежуточного бронха при правосторонней нижнедолевой пневмонии (88,2%), рассасывание инфильтрации легочной ткани через 10 дней (96,0%), из них полное рассасывание в 30,0% случаев, частичное рассасывание в 70,0% случаев, отсутствие уменьшения объема доли/долей легкого (94,0%), на КТ-срезах – отсутствие увеличенных внутригрудных лимфоузлов (98,0%), $p < 0,05$.

Злокачественный процесс в легких установлен в 11 (16,2%) наблюдениях, из них рак легкого в 9 (13,2%) случаях и метастатическое поражение легких и лимфоузлов средостения в 2 (3,0%) случаях. На рентгенограммах и КТ-срезах дифференциально-диагностическими критериями рака легкого были нарушение бронхиальной проходимости (100%) в виде ампутации (33,3%) и сужения бронха (66,7%), увеличение внутригрудных лимфоузлов (88,9%), из них паратрахеальной и бифуркационной группы (88,9%), $p < 0,05$.

Инфильтративный туберкулез легких в фазе распада и обсеменения установлен в 5 (7,3%) наблюдениях. Дифференциально-диагностическими критериями туберкулеза легких были вовлечение в процесс верхней доли (100%), из них S1-S2 (100%), смещение корня легкого вверх на стороне поражения (70%), наличие полостей распада с очагами засева вокруг (100%), наличие очаговых изменений в нижних долях легких (40%), увеличение

внутригрудных лимфоузлов с обызвествлением (40,0%), увеличение внутригрудных лимфоузлов, преимущественно трахеобронхиальной и бронхопульмональной группы (60,0%), фокусная инфильтрация (100%), $p < 0,05$.

Вывод

Лучевые методы исследования являются методами выбора в дифференциальной диагностике заболеваний легких, сопровождающихся синдромом консолидации.

Список литературы

1. Статистический сборник заболеваемости РК. – Астана, 2014.
2. М.Г. Тухбатуллин, Валиев Р.Ш., Шамшурова Е.С. Рентгено-ультразвуковая картина при инфильтративном туберкулезе легких. -2014. -Выпуск № 3 (79).

Тұжырым

Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.К. Жакенова, А.Н. Ахмұльдинова,
Ш.Н. Кудобаева, А.Ю. Талипова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

С.Д. Асфендияров атындағы Қаз ҰМУ
Қалалық клиникалық орталық аурухана
Аудандық орталық аурухана, Алматы обл.
Консолидация синдромы

Консолидация синдромы шоғырландыру анықтамасын ұсынады. Радиологиялық (X-Ray, компьютерлік томография) ғылыми-зерттеу әдістері өкпе шоғырландыру синдромы бар 68 науқас нәтижелерін талдау. Пневмония, туберкулез және өкпе қатерлі ісігі айтарлықтай дифференциалды диагностикалау рентген белгілері бейнеленеді.

Түйінді сөздер: X-Ray, компьютерлік томография, консолидация синдромы, диагностикалау рентген белгілері бейнеленеді.

Summary

Zh. Zh. Zholdybay, Zh.K. Zhakenova, A.N. Ahmudina, Sh.N. Kudobaeva, A.U. Talipova

Kazakh Institute of Oncology and Radiology,
Asfendiarov Kazakh National University,
CCCH, c. Almaty, RCH, c. Almaty

The syndrome of consolidation in the lung

The paper presents the definition of the syndrome consolidation. The analysis of the results of the radiology images of 68 patients with the syndrome of consolidation in the lung. The significant differential diagnostic radiology symptoms of pneumonia, tuberculosis and lung cancer were identified.

Key words: radiology images, syndrome consolidation, diagnostic radiology symptoms.